Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Lifting temporal

Remontée de la queue du sourcil et du coin externe de l'œil par voie temporale (lifting latéral du sourcil)

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Établissement de santé où sera réalisée l'intervention : _____

Côté : ☐ Droit ☐ Gauche ☐ Des deux côtés

Site d'incision : ☐ Dans le cuir chevelu (tempe) ☐ À la lisière des cheveux ☐ À déterminer pendant l'intervention _____

Méthode de fixation : ☐ Points de suture permanents ☐ Dispositif résorbable ☐ Autre _____

Interventions réalisées dans le même temps : ☐ Blépharoplastie supérieure (consentement séparé) ☐ Injection de graisse ☐ Aucune _____

Plaintes et attentes du patient : _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

Avec l'âge, les tissus du front et des tempes se relâchent ; en particulier, l'**extrémité externe du sourcil** et le **coin externe de l'œil** descendent. Cela peut donner un regard fatigué, triste ou lourd, une impression d'excès de peau sur la paupière supérieure et des rides au coin de l'œil. Chez certaines personnes, cette forme est également présente dès la naissance.

Le lifting temporal est une intervention qui **remonte la partie externe du sourcil et le coin de l'œil vers le haut et vers l'arrière** grâce à de petites incisions situées dans les cheveux des tempes. Son objectif est d'obtenir un **regard plus frais et plus ouvert**, en harmonie avec votre visage. À lui seul, il ne corrige ni la partie interne du sourcil, ni l'ensemble du front, ni l'excès de peau des paupières ; si nécessaire, il est associé à d'autres interventions.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Comment se déroule l'intervention ?

L'intervention est habituellement réalisée sous anesthésie générale, ou sous sédation associée à une anesthésie locale, au bloc opératoire. Au préalable, la position de vos sourcils et des coins de vos yeux est évaluée en position debout et assise, des photographies sont prises et la direction de la remontée est marquée avec vous.

1. **Incision :** de chaque côté, des incisions d'environ 3–5 cm sont réalisées dans les cheveux de la tempe ou à la lisière des cheveux. Les cheveux ne sont pas coupés, ou seule une bande très étroite le long de l'incision est égalisée.
2. **Libération des tissus :** le chirurgien travaille dans le plan profond de la tempe, de manière à protéger la branche frontale du nerf facial. Les tissus conjonctifs situés autour de la partie externe du sourcil et du coin de l'œil sont délicatement libérés afin de pouvoir être mobilisés.
3. **Remontée et fixation :** les tissus libérés sont remontés vers le haut et vers l'arrière dans la direction prévue, puis fixés à la couche de tissu solide de la tempe à l'aide de **points de suture permanents** ou de **dispositifs de fixation résorbables**. L'équilibre entre les deux côtés est vérifié.
4. **Fermeture :** si nécessaire, un petit excédent de cuir chevelu est retiré. Les incisions sont refermées par des agrafes ou des points de suture, un drain fin est parfois mis en place et un pansement léger est appliqué autour de la tête.

Si une chirurgie de la paupière supérieure (blépharoplastie) ou une autre intervention doit être réalisée dans le même temps, un **formulaire de consentement séparé** sera signé pour celle-ci.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Anesthésie générale ou sédation + anesthésie locale	Environ 1–2 heures	Généralement sortie le jour même ou une nuit à l'hôpital

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Un regard plus frais, plus ouvert et plus jeune grâce à la remontée de la partie externe du sourcil et du coin de l'œil
- Diminution de la lourdeur et de l'impression d'excès de peau sur la partie externe de la paupière supérieure
- Aucune cicatrice visible sur le visage, les incisions étant cachées dans les cheveux

La plupart des patients correctement sélectionnés sont satisfaits du résultat. Au cours des premières semaines, les sourcils peuvent paraître légèrement plus hauts que prévu ; cela s'atténue à mesure que les tissus se mettent en place. Le résultat définitif est visible en **3–6 mois**. Les tissus remontés peuvent redescendre quelque peu avec le temps, sous l'effet du vieillissement et de la pesanteur ; la durée de l'effet varie d'une personne à l'autre et est généralement de **plusieurs années**. Environ **5–10 patients sur 100** peuvent avoir besoin d'une retouche en raison d'une asymétrie ou d'un relâchement précoce.

4 Autres options thérapeutiques

- **Ne pas se faire opérer :** s'agissant d'une intervention esthétique, vous avez toujours la possibilité de ne pas la réaliser.
- **Remontée du sourcil par toxine botulique :** peut relever la partie externe du sourcil de quelques millimètres, de façon temporaire (3–4 mois).
- **Techniques de lifting par fils :** réalisées avec moins d'incisions, mais leur effet est généralement plus limité et de plus courte durée.
- **Produits de comblement pour soutenir la tempe/le sourcil :** peuvent apporter une amélioration temporaire lorsque l'affaissement est dû à une perte de volume ; ils comportent leurs propres risques, comme l'obstruction d'un vaisseau sanguin.
- **Autres interventions de remontée du sourcil :** si l'ensemble du front et la partie interne du sourcil sont également affaissés, un lifting frontal endoscopique ou des techniques avec incision au-dessus du sourcil ou à la lisière des cheveux peuvent être plus adaptés.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Blépharoplastie supérieure seule :** peut suffire si le problème principal est l'excès de peau de la paupière ; elle ne corrige pas un sourcil bas.

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Si l'intervention n'est pas réalisée, l'aspect actuel de vos sourcils et des coins de vos yeux restera inchangé et le vieillissement naturel se poursuivra. Cela ne représente pas de danger pour votre santé.

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- Des analyses de sang et, si nécessaire, d'autres examens sont réalisés avant l'intervention ; si une anesthésie générale est prévue, vous serez évalué(e) par le médecin anesthésiste.
- Ne mangez et ne buvez rien pendant les **6–8 heures** précédant l'intervention (suivez les consignes du médecin anesthésiste).
- Lavez-vous les cheveux la veille au soir ou le matin de l'intervention ; le jour même, n'utilisez ni laque, ni gel, ni maquillage, ni lentilles de contact. Il n'est généralement pas nécessaire de couper vos cheveux.
- Informez votre médecin si vous avez reçu des injections de toxine botulique dans la région du front ou des sourcils au cours des **3–4 derniers mois** ; cela peut influencer la planification.
- Il est recommandé qu'un proche reste avec vous le premier jour suivant l'intervention.
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

Premières 48 heures	Vous ressentirez une sensation de tension, de légers maux de tête et un gonflement au niveau des tempes et du front ; la douleur est généralement légère et soulagée par les antalgiques. Le gonflement peut descendre vers les yeux ; des ecchymoses, **si elles apparaissent**, se situent sur les paupières. Dormir la tête surélevée et appliquer des compresses froides aident à réduire le gonflement. Si un drain a été mis en place, il est généralement retiré le lendemain.
1re semaine	Vous pouvez généralement vous laver doucement les cheveux avec un shampooing doux à partir du **2e–3e jour**. À ce stade, les sourcils et les coins des yeux peuvent paraître plus hauts et plus tirés que prévu. La plupart des patients reprennent leurs activités quotidiennes et un travail de bureau en 5–7 jours.
Jours 7–14	Les agrafes ou les points de suture sont retirés. Un engourdissement, des démangeaisons et une sensibilité le long de l'incision au niveau des tempes peuvent persister.
Semaines 2–6	Le gonflement disparaît en grande partie et le regard devient plus naturel. Le sport intense et les bandeaux/casques serrés qui appuient sur les tempes doivent être évités pendant au

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	moins **3–4 semaines**, et les colorations capillaires et traitements chimiques similaires pendant au moins **4–6 semaines** ; utilisez votre sèche-cheveux en position tiède.
Mois 3–6	Les tissus se mettent en place et l'aspect définitif apparaît. Les modifications de sensibilité du cuir chevelu récupèrent en grande partie ; la cicatrice s'estompe.

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Sensation de tension, de pression et légers maux de tête au niveau des tempes et du front
- Gonflement du front et du pourtour des yeux ; les ecchymoses, **si elles apparaissent**, disparaissent en 1–2 semaines
- Sourcils paraissant plus hauts que prévu, ou air étonné, au cours des premières semaines
- Engourdissement, démangeaisons ou fourmillements des tempes et du cuir chevelu
- Sensibilité et induration le long de l'incision

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Légère asymétrie** — Les sourcils ne sont naturellement pas parfaitement symétriques ; de légères différences entre les deux côtés peuvent persister après l'intervention ou apparaître pendant la cicatrisation.
- **Raréfaction des cheveux le long de l'incision** — Une chute temporaire des cheveux autour de l'incision (effluvium post-opératoire, « shock loss ») est fréquente, et les cheveux repoussent généralement en **2–4 mois**. L'incision reste sous la forme d'une fine ligne recouverte par les cheveux.
- **Engourdissement et démangeaisons prolongés** — Les modifications de sensibilité du cuir chevelu peuvent durer plusieurs mois ; des démangeaisons pendant la cicatrisation sont normales.
- **Relâchement partiel** — Une certaine redescente des tissus remontés est attendue au cours des premiers mois ; c'est pourquoi une légère surcorrection peut être réalisée pendant l'intervention.

Situations peu fréquentes

- **Faiblesse temporaire pour lever le sourcil (branche frontale du nerf facial)** — Chez environ **1–3 patients sur 100**, une faiblesse temporaire pour lever le sourcil ou plisser le front d'un côté peut survenir. Elle est généralement due à un étirement du nerf ou au gonflement et récupère spontanément en **quelques semaines à quelques mois**.
- **Perte de cheveux définitive ou cicatrice élargie** — Une zone définitivement dépourvue de cheveux ou une cicatrice élargie le long de l'incision peut rarement apparaître ; les cicatrices situées à la lisière des cheveux, en particulier, peuvent être plus visibles. Si nécessaire, elle peut être améliorée par une reprise de cicatrice ou une greffe de cheveux.
- **Hématome (accumulation de sang)** — Chez environ **1–2 patients sur 100**, du sang peut s'accumuler dans la tempe ; il peut être nécessaire de l'évacuer à l'aiguille ou par un petit geste.
- **Infection** — Survient chez **moins de 1 patient sur 100**. Elle guérit généralement sous antibiotiques ; rarement, un drainage du pus ou le retrait d'un point de fixation est nécessaire.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Surcorrection : air « étonné » ou regard trop étiré (« fox eye »)** — La partie externe du sourcil ou le coin de l'œil peut paraître plus remonté que souhaité. Cela s'atténue généralement à mesure que les tissus se mettent en place au cours des premières semaines ; si cela persiste, une retouche peut être nécessaire.
- **Redescente précoce ou effet insuffisant** — En raison d'un relâchement de la fixation ou de la nature des tissus, le sourcil peut redescendre plus tôt que prévu ; une nouvelle remontée peut être nécessaire.
- **Problèmes liés au matériel de fixation** — Un point de suture ou un dispositif permanent peut être perçu sous la peau, être sensible ou, rarement, se frayer un chemin à travers la peau ; dans ce cas, il peut être nécessaire de le retirer.

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Lésion nerveuse définitive** — Une lésion définitive de la branche nerveuse qui commande le muscle releveur du sourcil est **très rare** (bien moins de 1 patient sur 100). Dans ce cas, le sourcil de ce côté ne se lève plus et le front ne se plisse plus ; une injection de toxine botulique du côté opposé ou une chirurgie complémentaire peut être nécessaire pour réduire l'asymétrie.
- **Engourdissement définitif ou douleur chronique** — Une perte définitive de sensibilité du cuir chevelu, une douleur prolongée due à un piégeage nerveux ou des maux de tête peuvent très rarement survenir ; un traitement complémentaire peut être nécessaire.
- **Altération de la vascularisation de la peau** — En particulier chez les fumeurs, des troubles de cicatrisation peuvent survenir sur les bords de l'incision, entraînant une cicatrice plus large et une perte de cheveux.
- **Difficulté à fermer les yeux et sécheresse oculaire** — Si une blépharoplastie supérieure a été réalisée lors de la même séance, une difficulté à fermer complètement l'œil et des symptômes de sécheresse oculaire peuvent rarement survenir ; ils sont le plus souvent temporaires.
- **Insatisfaction psychologique** — Malgré un résultat techniquement réussi, une personne peut avoir du mal à s'habituer à son nouveau regard. Discuter ouvertement des attentes avant l'intervention réduit ce risque.

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Risques liés à l'anesthésie :** Si une anesthésie générale ou une sédation est utilisée, ses risques (nausées, maux de gorge, lésion dentaire, réaction allergique et, très rarement, problèmes cardiaques ou pulmonaires) vous seront expliqués séparément par le médecin anesthésiste, et votre consentement sera recueilli sur un **formulaire de consentement à l'anesthésie distinct**.
- **Saignement et transfusion sanguine :** Le recours à une transfusion sanguine est très rare dans ces interventions. En cas de saignement important, du sang ou des produits sanguins peuvent être nécessaires ; ils comportent leurs propres risques, très rares (allergie ou infection, par exemple).
- **Infection :** Une infection de la plaie après l'opération est généralement traitée par antibiotiques ; rarement, un drainage (évacuation du pus) peut être nécessaire.
- **Caillots de sang dans les veines des jambes (thrombose veineuse profonde, TVP) et dans les poumons (embolie pulmonaire) :** Très rares lors des interventions courtes de la tête et du cou. Se lever et marcher tôt réduit le risque. Les traitements hormonaux, le tabac, l'obésité et des antécédents de caillots augmentent le risque.
- **Allergie médicamenteuse :** Une réaction allergique peut survenir aux médicaments, antiseptiques, sparadraps ou fils de suture utilisés.
- **Cicatrices et troubles de la cicatrisation :** L'aspect des cicatrices varie d'une personne à l'autre ; très rarement, une cicatrice épaisse (hypertrophique) ou une chéloïde peut se former.
- **Risque vital :** Le décès lors d'une chirurgie programmée de la tête et du cou est aujourd'hui extrêmement rare ; cependant, aucune intervention chirurgicale n'est totalement dénuée de risque. Une complication grave peut nécessiter une prise en charge en réanimation et entraîner un handicap permanent.

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

9 Quand nous contacter immédiatement

- **Gonflement de la tempe ou du front qui augmente rapidement, tendu et douloureux**
- **Saignement qui ne s'arrête pas** au niveau des incisions
- **Fièvre supérieure à 38,5 °C**, rougeur croissante, douleur, chaleur ou écoulement de pus au niveau des incisions
- **Maux de tête violents** non soulagés par les antalgiques, vomissements ou raideur de la nuque
- **Vision floue ou double**, douleur oculaire ou impossibilité de fermer l'œil
- Assombrissement, coloration violacée à noirâtre de la peau, ou ouverture de la plaie

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Pendant les 1–2 premières semaines, dormez sur le dos, la tête surélevée ; évitez de dormir sur le ventre ou sur les tempes.
- Pendant les 3–4 premières semaines, ne frottez pas vos sourcils ni votre front, ne massez pas vos tempes et évitez les gestes qui tirent votre visage vers le bas.
- Reportez d'au moins **4–6 semaines** les traitements chimiques et thermiques tels que les colorations, les permanentes et les lisseurs. Utilisez votre sèche-cheveux en position tiède.
- Évitez le sport intense, le fait de vous pencher, de porter des charges, le sauna et le hammam pendant les 3–4 premières semaines.
- Si vous venez de l'étranger, le voyage en avion est généralement sans danger après le premier contrôle, le plus souvent à partir du 3e–5e jour.
- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

11 Situations imprévues pendant l'intervention, prélèvements de tissus et produits sanguins

Si une situation imprévue survient pendant l'intervention, votre médecin restera dans le cadre de l'intervention à laquelle vous avez consenti dans ce formulaire. **Sauf en cas de danger vital ou de risque d'atteinte grave d'un organe**, aucun acte supplémentaire auquel vous n'avez pas consenti ne sera réalisé ; dans ce cas, l'intervention sera terminée à un stade sûr et vous serez informé(e) ensuite afin que la décision soit prise avec vous. Si votre vie est en danger, les soins d'urgence nécessaires pour protéger votre vie ou l'organe seront réalisés.

Les tissus retirés pendant l'intervention seront, si nécessaire, envoyés pour **examen anatomopathologique** afin de confirmer le diagnostic. Selon le résultat, un traitement ou un suivi complémentaire peut être nécessaire.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Une transfusion sanguine est très rarement nécessaire dans ces interventions et ne sera réalisée qu'en cas de nécessité vitale. Si vous n'acceptez pas le sang ou les produits sanguins (par exemple pour des raisons religieuses), vous devez nous le signaler avant l'intervention ; les conséquences possibles de cette décision seront discutées séparément avec vous et consignées dans la rubrique « Informations vous concernant personnellement ».

12 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

- ☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.
- ☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

13 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

14 Déclaration du patient

- ☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.
- ☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.
- ☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.
- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.
- ☐ Je comprends que le lifting temporal remonte la partie externe du sourcil et le coin de l'œil, et qu'à lui seul il ne corrige ni l'ensemble du front, ni la partie interne du sourcil, ni l'excès de peau des paupières.
- ☐ Je comprends qu'au cours des premières semaines les sourcils peuvent paraître plus hauts et plus tirés, que les tissus remontés peuvent redescendre quelque peu avec le temps et que l'effet n'est pas permanent.
- ☐ Je comprends que cette intervention est **à visée esthétique**, qu'elle n'est pas médicalement nécessaire et que j'ai toujours la possibilité de ne pas la faire. J'ai discuté de mes attentes avec mon médecin, et le résultat réaliste pouvant être obtenu m'a été expliqué.
- ☐ Je comprends qu'une symétrie parfaite ou la reproduction exacte de l'apparence d'une photographie ne peuvent être garanties, que le résultat final dépend de la cicatrisation de mes tissus et que, dans certains cas, une intervention de correction peut être nécessaire.

- ☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**
- ☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

15 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien avec le patient :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.

☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.